

Mirror Soul

Reporte generado por IA

Paciente: 4

Sesión: 266

Fecha: Thu Aug 06 2026 14:19:09 GMT-0600 (hora estándar central)

Contenido

Aquí tienes el reporte final preliminar basado en la sesión:

Reporte Clínico Preliminar

****Paciente:**** Luci, 11 años, F

****Fecha de Sesión:**** 29 de octubre de 2025

****1. Resumen Clínico Breve****

Luci es una paciente femenina de 11 años, estudiante de primaria. Los antecedentes emocionales reportan depresión, lo cual se alinea con la evaluación inicial. Se observa el hábito de morderse los labios. Existe una sospecha de ansiedad que requiere confirmación mediante pruebas. Su historial de desarrollo cognitivo y escolar es bueno, sin dificultades significativas. A nivel de salud física, presenta antecedentes de rinitis, cálculos renales y una fractura de codo derecho, además de tomar metformina e histofil.

****2. Patrones Observados en Pruebas y Notas****

Dada la ausencia de pruebas registradas en esta sesión, los patrones se extraen principalmente de la historia clínica:

* ****Patrón Emocional:**** Persistencia de antecedentes de depresión y una evaluación inicial que la sugiere. La mención de ansiedad como diagnóstico inicial (aunque pendiente de pruebas) refuerza un patrón de vulnerabilidad emocional.

* ****Conductual:**** Hábito de morderse los labios, lo cual podría ser un indicador de tensión, ansiedad o mecanismo de afrontamiento.

* ****Clínico/Metodológico:**** Las notas y el diagnóstico inicial ("ansiedad pero faltan pruebas") indican un patrón de necesidad de realizar pruebas diagnósticas para profundizar y confirmar las hipótesis clínicas actuales.

****3. Riesgos Detectados****

* ****Riesgo Emocional:**** La presencia de antecedentes y una evaluación inicial de depresión, junto con la sospecha de ansiedad, representa un riesgo significativo para el bienestar emocional y desarrollo psicosocial de Luci a su edad. Estos estados pueden afectar su rendimiento escolar, relaciones interpersonales y autoconcepto.

* ****Riesgo de Subdiagnóstico/Tratamiento Tardío:**** Al no contar aún con pruebas confirmatorias o un tratamiento establecido, existe el riesgo de que los síntomas emocionales de Luci progresen o se cronifiquen si no se interviene de manera oportuna y precisa.

****4. Recomendaciones de Seguimiento****

1. ****Evaluación Diagnóstica Integral:**** Priorizar la aplicación de un set completo de pruebas psicométricas y proyectivas adecuadas para la edad de Luci. Esto debe incluir instrumentos que evalúen depresión (ej. BDI-II adaptado para niños, CDI) y ansiedad (ej. Spence Children's Anxiety Scale, SCAS), así como escalas para evaluar el funcionamiento general y la calidad de vida.
2. ****Entrevista Clínica Profundizada:**** Realizar una entrevista más exhaustiva con Luci y sus cuidadores para explorar la historia de la depresión, los factores precipitantes y mantenedores, el impacto en su funcionamiento diario y el contexto familiar y social.
3. ****Plan de Tratamiento:**** Una vez se disponga de un diagnóstico más claro y completo, diseñar un plan de tratamiento individualizado que pueda incluir psicoterapia (ej. Terapia Cognitivo-Conductual adaptada para niños y adolescentes) y, si es necesario, evaluación psiquiátrica para considerar intervención farmacológica.

****5. Observaciones sobre Multimedia****

No se proporcionaron elementos multimedia para esta sesión.

****6. Nota Aclaratoria****

Este reporte es de carácter preliminar y se basa en la información disponible hasta el momento de esta sesión. Las impresiones y recomendaciones aquí expresadas no constituyen un diagnóstico definitivo. Se requiere una evaluación exhaustiva y continuada, incluyendo la administración de pruebas diagnósticas, para establecer un diagnóstico preciso y diseñar un plan de intervención adecuado para la paciente Luci.
